

Module 3.4

Mouvements Anormaux

QCM 2019

PD Dr David Benninger
Service de Neurologie



Département des
Neurosciences Cliniques



Parkinsonisme

laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est/sont correcte(s) ?

- A) Il est diagnostiqué par la présence de 2 des signes suivants : tremblement, rigidité, bradykinésie
- B) Il n'affecte que les personnes âgées
- C) La maladie de Parkinson est la cause principale
- D) Il est un des effets secondaires fréquents des neuroleptiques

Parkinsonisme

DD Parkinson vs atypique ou -plus



Gowers, 1893

- bradykinésie
 - hypokinésie / akinésie
- tremblement
- rigidité
- troubles de la posture
- instabilité posturale, chutes
- troubles de la marche, blocage



Shuffling Gait



Mask-like Expression



Postural Instability

Parkinsonisme: étiologies

- primaire: maladie de Parkinson idiopathique, héréditaire
- Parkinsonisme (secondaire)
 - médicaments, toxiques, vasculaires, post-encéphalite
- Parkinson-Plus = Parkinson atypique
 - paralysie supranucléaire progressive (PSP)
 - dégénérescence corticobasale (CDB)
 - atrophie multisystémique (MSA)
 - Démence à corps de Lewy

Parkinsonisme

- fréquent:
maladie de Parkinson
complication médicamenteuse
démence à corps de Lewy
atrophie multi-systémique
paralysie supranucléaire progressive
- rare:
vasculaire P.
dégénérescence cortico-basale
Alzheimer
dégénérescence frontotemporale
maladie de Wilson
maladie de Huntington
tumeur
hydrocéphalie
toxique

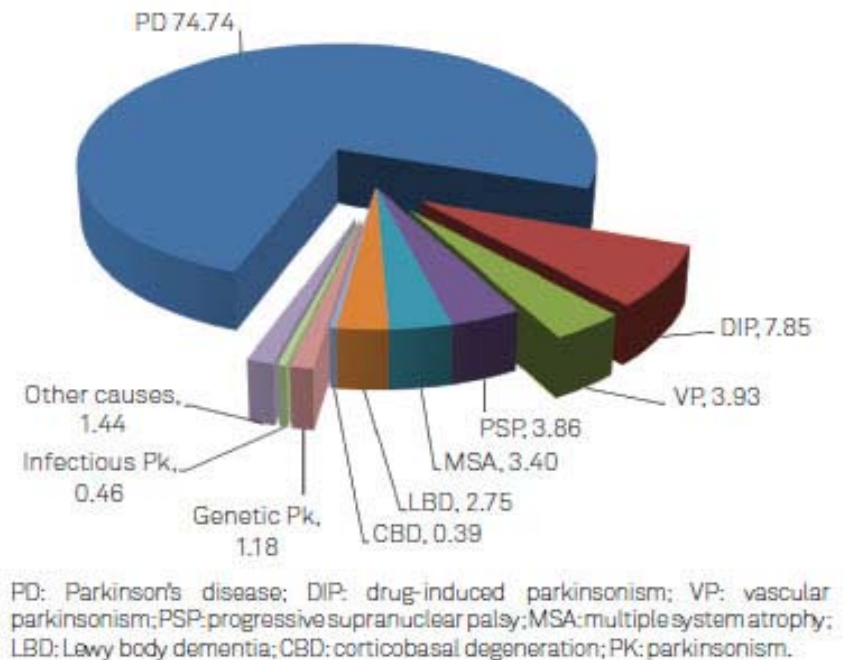


Fig 1. Causes of parkinsonism. Final diagnoses from our movement disorders clinic as presented by Munhoz et al.⁴. All values are presented in percentages (n=1528).

Parkinsonisme

laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est/sont correcte(s) ?

- A) Il est diagnostiqué par la présence de 2 des signes suivants : tremblement, rigidité, bradykinésie
- B) Il n'affecte que les personnes âgées
- C) La maladie de Parkinson est la cause principale
- D) Il est un des effets secondaires fréquents des neuroleptiques

La maladie de Parkinson se caractérise par la/les constatation(s) suivante(s) ?

- A) parkinsonisme asymétrique
- B) absence de réponse à la L-dopa
- C) n'affecte pas de personnes de moins de 40 ans
- D) instabilité posturale et chutes précoces

Maladie de Parkinson

- maladie neurodégénérative
- parkinsonisme progressive asymétrique
 - **bradykinésie** / hypokinésie / akinésie
 - **± tremblement**
 - **± rigidité**
 - plus tard: instabilité posturale, troubles de posture, blocage
- Exclusion d'autres causes
- Réponse à la L-dopa (> ans)
- fluctuations motrices & dyskinésies

La maladie de Parkinson se caractérise par la/les constatation(s) suivante(s) ?

- A) parkinsonisme asymétrique
- B) absence de réponse à la L-dopa
- C) n'affecte pas de personnes de moins de 40 ans
- D) instabilité posturale et chutes précoces

Une patiente de 55 ans, droitère, vous consulte pour un tremblement de la main droite avec une difficulté dans les mouvements fins et une écriture plus petite depuis 6 mois.

A l'examen clinique, elle présente une **bradykinésie et une rigidité à droite avec tremblement au repos intermittent**. Le reste de l'examen est normal. Absence de troubles à la marche et de la stabilité posturale. **Le diagnostic le plus probable:**

- A) dégénérescence cortico-basale
- B) atrophie multi-systématisée
- C) paralysie supra-nucléaire progressive
- D) maladie de Parkinson
- E) hydrocéphalie à pression normale

Une patiente de 55 ans, droitère, vous consulte pour un tremblement de la main droite avec une difficulté dans les mouvements fins et une écriture plus petite depuis 6 mois.

A l'examen clinique, elle présente une **bradykinésie et une rigidité à droite avec** tremblement au repos intermittent. Le reste de l'examen est normal. Absence de troubles à la marche et de la stabilité posturale. **Le diagnostic le plus probable:**

- A) dégénérescence cortico-basale
- B) atrophie multi-systématisée
- C) paralysie supra-nucléaire progressive
- D) **maladie de Parkinson**
- E) hydrocéphalie à pression normale

Un patient de 70 ans vous consulte pour des chutes fréquentes et un ralentissement progressif depuis 6 mois.

A l'examen clinique il présente une **rigidité à prédominance axiale, une bradykinésie généralisée symétrique, et une abolition des mouvements oculaires volontaires verticaux, une chute** en bloc lors du pull-test.

Le diagnostic le plus probable est :

- A) maladie de Parkinson
- B) atrophie multi-systématisée
- C) paralysie supra-nucléaire progressive
- D) dégénérescence cortico-basale
- E) hydrocéphalie à pression normale

Maladie de Parkinson

association de 2/3 signes principaux:

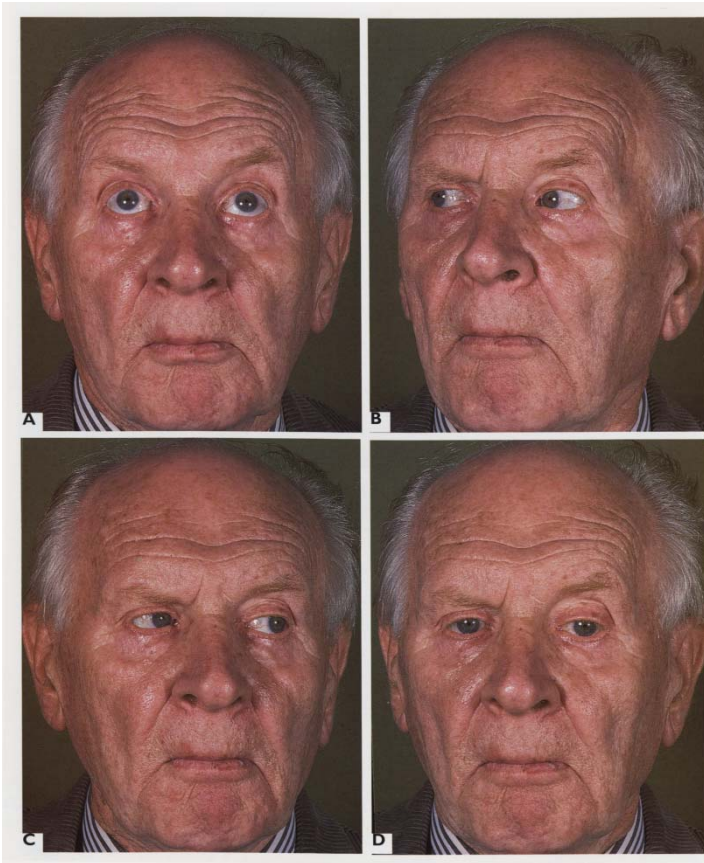
- bradykinésie
 - hypokinésie / akinésie
- tremblement
- rigidité

stades avancés (si précoces DD atypique)

- troubles de la posture
- instabilité posturale, chutes
- troubles de la marche, blocage

Parkinson-Plus:

Paralysie supranucléaire progressive



- = **paralysie de l'oculomotricité (regard)** surtout vertical
- **rigidité / akinésie axiale** > proximale
- **instabilité posturale / trouble marches avec chutes**
- posture cervicale anormale (rétrocollis)
- absence ou minime réponse à la L-dopa
- troubles cognitifs précoces (frontaux), syndrome frontal
- dysphagie précoce et dysarthrie
- apathie
- Pathologie: tau protéine
 - sporadique
 - rare: familiale (mutation tau)

Parkinson-Plus:

Atrophie multisystémique (MSA)

- Syndrome parkinsonien dopa-résistant (MSA-P)
- Hypotension orthostatique, syncopes
- Incontinence urinaire, impuissance
- Troubles de la coordination / marche (ataxie) : MSA-C
- Dysarthrie
- Syndrome pyramidal (faiblesse, spasticité)
- Sporadique

Troubles
végétatifs

Un patient de 70 ans vous consulte pour des chutes fréquentes et un ralentissement progressif depuis 6 mois.

A l'examen clinique il présente une **rigidité à prédominance axiale, une bradykinésie généralisée symétrique, et une abolition des mouvements oculaires volontaires verticaux, une chute** en bloc lors du pull-test.

Le diagnostic le plus probable est :

- A) maladie de Parkinson
- B) atrophie multi-systématisée
- C) paralysie supra-nucléaire progressive
- D) dégénérescence cortico-basale
- E) hydrocéphalie à pression normale

Un patient de 50 ans vous consulte pour un tremblement postural des deux bras et à l'action (écriture), absent au repos, le reste de l'examen est normal.

Vous pensez à un tremblement essentiel.

Quelle(s) constatation(s) soutie(nne)nt ce diagnostic :

- A) amélioration avec l'alcool
- B) apparition brutale
- C) dysmétrie index-nez
- D) histoire familiale

Tremblement: DD

	Parkinson	Tr. essentiel
Histoire familiale	(Négative)	Positive 50%
Age	Soixantaine	Tout
Alcool	Peu sensible	Sensible
Tremblement	Repos > Posture >> action	Posture > action >> repos
Distribution	asymétrique	MS, tête et voix
<u>Traitement</u>	Tôt	Tard
Levodopa	++	-
Propranolol	+	+
Primidone	-	+

Un patient de 50 ans vous consulte pour un tremblement postural des deux bras et à l'action (écriture), absent au repos, le reste de l'examen est normal.

Vous pensez à un tremblement essentiel.

Quelle(s) constatation(s) soutie(nne)nt ce diagnostic :

- A) amélioration avec l'alcool
- B) apparition brutale
- C) dysmétrie index-nez
- D) histoire familiale

Bonne chance!